ΜΠΟΝΟΥΣ 2

Τα 50 Λάθη Γνωμάτευσης που Διορθώνει Συχνότερα ο Επιμελητής

50 λάθη που κάνουν τις γνωματεύσεις να επιστρέφουν· το καθένα με τη δομή «Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί». Διορθώστε τη γνωμάτευσή σας πριν τη συναντήσει το κόκκινο στυλό του επιμελητή σας.

Περιεχόμενα

Πώς χρησιμοποιείται αυτή η λίστα

Τεχνική και σύγκριση — 6 λάθη

Ορολογία — 7 λάθη

Εντόπιση, πλευρά και μέτρηση — 8 λάθη

Ευρήματα — 9 λάθη

Συμπέρασμα — 8 λάθη

Σύσταση — 4 λάθη

Επείγον εύρημα και ενημέρωση — 4 λάθη

Μορφή και πριν από την υπογραφή — 4 λάθη

Επόμενο βήμα

ΓΙΑ ΑΡΧΗ

Πώς χρησιμοποιείται αυτή η λίστα

Τα λάθη είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα με τη μέθοδο των 4 βημάτων: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ, ΣΑΡΩΣΤΕ, ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ, ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ.

> *Τα περισσότερα λάθη στις γνωματεύσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη γνώσεων, αλλά σε συνήθεια. Και η συνήθεια διορθώνεται μόλις τη συνειδητοποιήσετε.*

ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ	ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΛΑΘΩΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	Τεχνική και σύγκριση
ΣΑΡΩΣΤΕ	Ευρήματα (παραλείψεις και σημαντικά αρνητικά ευρήματα)
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ	Ορολογία · Εντόπιση, πλευρά και μέτρηση · Ευρήματα
ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ	Συμπέρασμα · Σύσταση · Επείγον εύρημα και ενημέρωση · Μορφή και πριν από την υπογραφή

1. **Για μία εβδομάδα, διαβάζετε κάθε μέρα μία ομάδα.** Οκτώ ομάδες, οκτώ ημέρες.
2. **Αντιστοιχίστε κάθε γνωμάτευση που διόρθωσε ο επιμελητής σας με αυτή τη λίστα.** Αν το ίδιο λάθος επαναλαμβάνεται δύο φορές, προσθέστε το στη λίστα ελέγχου σας.
3. **Πριν από την υπογραφή, εφαρμόστε τη Λίστα Ελέγχου Γνωμάτευσης σε Μία Σελίδα.** Τα σημεία της λίστας είναι η σύνοψη αυτών των 50 λαθών.

Πρακτική του ιδρύματος

Αν η μορφή γνωμάτευσης ή οι προτιμήσεις ορολογίας της κλινικής σας διαφέρουν από τα παραδείγματα εδώ, ισχύει ο κανόνας της κλινικής σας. Ο κύριος στόχος είναι να κατανοήσετε την αρχή: γνωμάτευση σαφής, μετρημένη, συγκριτική και που απαντά στο ερώτημα.

ΟΜΑΔΑ 1

Τεχνική και σύγκριση

6 λάθη · Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
01	Το πεδίο Τεχνική έμεινε κενό.	«Αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· οι αξονικές τομές εκτιμήθηκαν σε παράθυρο εγκεφάλου και οστικό παράθυρο.»	*Ο αναγνώστης δεν μπορεί να σταθμίσει την ισχύ των ευρημάτων αν δεν ξέρει ποια εξέταση εκτιμήθηκε και υπό ποιες συνθήκες.*
02	«Αξονική τομογραφία κοιλίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.»	«Αξονική τομογραφία κοιλίας-πυέλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, πυλαία φλεβική φάση.»	*Η φάση καθορίζει αν ένα εύρημα θα φανεί ή όχι· χωρίς πληροφορία για την αρτηριακή φάση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ενεργός αιμορραγία.*
03	Δεν γράφτηκε η τεχνική ανεπάρκεια (τεχνικό σφάλμα κίνησης, ανεπαρκής εισπνοή).	«Λόγω τεχνικού σφάλματος κίνησης, η εκτίμηση του οπίσθιου κρανιακού βόθρου είναι περιορισμένη.»	*Αν δεν γραφτεί ο περιορισμός, η φράση «χωρίς ευρήματα» διαβάζεται πιο αξιόπιστη απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα.*
04	«Έγινε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση.»	«[Ημερομηνία] — σύγκριση με την αξονική τομογραφία θώρακα αυτής της ημερομηνίας.»	*Χωρίς ημερομηνία και απεικονιστική μέθοδο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ποια εξέταση έγινε η σύγκριση.*
05	Δεν έγινε σύγκριση, ενώ υπάρχει προηγούμενη εξέταση.	«Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση, το μέγεθος του όζου [.. mm] → [.. mm]: αυξήθηκε.»	*Το βασικό ερώτημα της εξέτασης παρακολούθησης είναι συνήθως η μεταβολή· χωρίς σύγκριση η γνωμάτευση δεν απαντά στο ερώτημα.*
06	«Σύγκριση: καμία.»	«Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.»	*Το «Όχι» είναι ασαφές: δεν υπάρχει στο σύστημα ή δεν ελέγχθηκε; Μια σαφής πρόταση εξαλείφει αυτό το ερώτημα.*

ΟΜΑΔΑ 2

Ορολογία

7 λάθη · Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
07	Στην αξονική «υπερέντονη βλάβη».	Στην αξονική «υπέρπυκνη βλάβη».	*Στην αξονική χρησιμοποιείται η πυκνότητα, στη μαγνητική το σήμα και στο υπερηχογράφημα η ηχογένεια· ο λάθος όρος δίνει την εντύπωση ότι δεν γνωρίζετε την απεικονιστική μέθοδο.*
08	Στο υπερηχογράφημα «υπόπυκνη μάζα».	Στο υπερηχογράφημα «υποηχογενής μάζα».	*Η ηχογένεια είναι όρος αποκλειστικά του υπερηχογραφήματος.*
09	Για κύστη «υποηχογενής».	Για απλή κύστη «άνηχη».	*Το άνηχο και το υποηχογενές σημαίνουν διαφορετικό περιεχόμενο· η διάγνωση απλής κύστης βασίζεται σε αυτή τη διαφορά.*
10	«Παρατηρείται όγκος.»	«[.. mm] βλάβη τύπου μάζας.»	*Ο όγκος είναι ιστολογική διάγνωση· το απεικονιστικό εύρημα περιγράφεται ως μάζα ή βλάβη.*
11	«Διήθηση» (για κάθε σκίαση στην ακτινογραφία).	Περιγραφικός όρος, όπως «πύκνωση», «θολή υάλου», «δικτυωτή σκίαση».	*Η «διήθηση» είναι ασαφής και έχει διαφορετική σημασία για διαφορετικούς ιατρούς.*
12	«Υπάρχει πιεστική επίδραση.»	«Εξάλειψη των αυλάκων, πίεση της ομόπλευρης πλάγιας κοιλίας και [.. mm] μετατόπιση της μέσης γραμμής.»	*Ο βαθμός της πιεστικής επίδρασης πρέπει να δίνεται με μέτρηση και ευρήματα· η κλινική απόφαση αλλάζει ανάλογα.*
13	«Εντός φυσιολογικών ορίων» (για τα πάντα).	Γράψτε σύντομα ένα-ένα τα σχετικά όργανα: «Ήπαρ, σπλήνας και νεφροί φυσιολογικοί.»	*Μένει ασαφές τι εκτιμήθηκε· ο αναγνώστης δεν μπορεί να καταλάβει ποιο όργανο παραλείφθηκε.*

ΟΜΑΔΑ 3

Εντόπιση, πλευρά και μέτρηση

8 λάθη · Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
14	Δεν γράφτηκε πλευρά: «Πλευριτική συλλογή.»	«Δεξιά πλευριτική συλλογή.»	*Η έλλειψη πλευράς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό λάθος σε επεμβάσεις όπως η θωρακοκέντηση ή η χειρουργική.*
15	Λάθος πλευρά που έμεινε από το πρότυπο.	Η πλευρά ελέγχεται δεύτερη φορά με τη σήμανση πάνω στην εικόνα και με το παραπεμπτικό.	*Είναι το πιο επικίνδυνο λάθος αντιγραφής-επικόλλησης· η πλευρά στα Ευρήματα και στο Συμπέρασμα πρέπει να είναι ίδια.*
16	«Βλάβη στον αριστερό πνεύμονα.»	«Βλάβη στο κορυφαίο τμήμα του αριστερού κάτω λοβού.»	*Η πληροφορία λοβού και τμήματος χρειάζεται τόσο στην παρακολούθηση όσο και στον σχεδιασμό βρογχοσκόπησης ή βιοψίας.*
17	«Μεγάλη μάζα», «μικρός όζος».	«[.. x .. mm] μάζα», «[.. mm] όζος».	*Τα επίθετα δεν είναι μετρήσεις· η μεταβολή στην παρακολούθηση μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με αριθμούς.*
18	Μετρήθηκε μία μόνο διάσταση, χωρίς να αναφέρεται το επίπεδο.	«Στο αξονικό επίπεδο [.. x .. mm], κρανιοουραία [.. mm].»	*Η μέτρηση σε διαφορετικό επίπεδο δίνει στην παρακολούθηση ψευδή εντύπωση αύξησης ή μείωσης.*
19	Η μέτρηση δεν έχει μονάδα: «Όζος 8.»	«Όζος [.. mm].»	*Ένας αριθμός χωρίς μονάδα μπορεί να διαβαστεί λάθος και δεν είναι υπερασπίσιμος ιατρονομικά.*
20	Σε βλάβη του ήπατος «στον δεξιό λοβό».	«Στο τμήμα [..]».	*Η πληροφορία τμήματος είναι στάνταρ για τον χειρουργικό και τον επεμβατικό σχεδιασμό.*
21	Στο κάταγμα πλευράς δεν υπάρχει αρίθμηση.	«Δεξιά [..] η πλευρά: κάταγμα στο πλάγιο τόξο.»	*Ποια πλευρά έχει κάταγμα είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση και τη συσχέτιση με την κλινική εξέταση.*

ΟΜΑΔΑ 4

Ευρήματα

9 λάθη · Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
22	Σταματήσατε στο πρώτο εύρημα· το δεύτερο εύρημα παραλείφθηκε.	Κάθε περιοχή σαρώνεται κάθε φορά με την ίδια σειρά· γράφεται και το δεύτερο εύρημα.	*Το «σταματώ μόλις βρω ένα εύρημα» (satisfaction of search) είναι η συχνότερη αιτία παράλειψης.*
23	Δεν γράφτηκε το σημαντικό αρνητικό εύρημα (στο ερώτημα σκωληκοειδίτιδας δεν αναφέρεται η σκωληκοειδής απόφυση).	«Η σκωληκοειδής απόφυση έχει φυσιολογική εικόνα· δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ οξείας σκωληκοειδίτιδας.»	*Αν δεν γραφτεί το όργανο που αφορά το κλινικό ερώτημα, ο κλινικός ιατρός δεν μπορεί να ξέρει αν εκτιμήθηκε ή όχι.*
24	Στο ερώτημα αιμορραγίας δεν αναφέρεται το οστικό παράθυρο.	«Στο οστικό παράθυρο δεν παρατηρείται κάταγμα του θόλου του κρανίου.»	*Στην αξονική τομογραφία τραύματος η εκτίμηση καταγμάτων απαιτεί οστικό παράθυρο· αν δεν γραφτεί, θεωρείται ότι δεν ελέγχθηκε.*
25	Τα Ευρήματα αναμειγνύονται με ερμηνεία: «Παρατηρείται πνευμονία.»	Στα Ευρήματα: «Πύκνωση με αεροβρογχογράμματα.» Στο Συμπέρασμα: «Μπορεί να είναι συμβατή με πνευμονία.»	*Τα Ευρήματα περιέχουν την παρατήρηση, το Συμπέρασμα την ερμηνεία· όταν τα δύο αναμειγνύονται, η γνωμάτευση γίνεται δύσκολα υπερασπίσιμη.*
26	Δεν αναφέρονται σωλήνες και καθετήρες.	«Το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα (ΕΤΤ) βρίσκεται **[.. cm]** πάνω από την τρόπιδα· το άκρο του ΚΦΚ στην προβολή της άνω κοίλης φλέβας.»	*Το συχνότερο κλινικό ερώτημα στις ακτινογραφίες της εντατικής είναι η θέση των συσκευών.*
27	Παραλείφθηκαν άλλες δομές στο πεδίο απεικόνισης (άνω κοιλία στην αξονική θώρακος).	«Στις τομές της άνω κοιλίας που απεικονίζονται **[δεν παρατηρείται παθολογία/..]**.»	*Κάθε δομή στο πεδίο απεικόνισης είναι ευθύνη αυτού που γνωματεύει· οι βλάβες επινεφριδίων ή ήπατος συχνά διαφεύγουν.*
28	Το ίδιο εύρημα επαναλαμβάνεται τρεις φορές στα Ευρήματα.	Κάθε εύρημα γράφεται μία φορά, κάτω από το αντίστοιχο όργανο.	*Η επανάληψη μακραίνει τη γνωμάτευση και δυσκολεύει τον αναγνώστη να βρει το κύριο εύρημα.*
29	Οστική βλάβη χωρίς περιγραφή: «Βλάβη στο οστό.»	«**[Οστό]**: **[.. mm]**, **[λυτική/σκληρυντική]**, **[στενή/ευρεία]** ζώνη μετάβασης της βλάβης· περιοστική αντίδραση **[όχι/ναι]**.»	*Ο χαρακτήρας της οστικής βλάβης (ζώνη μετάβασης, θεμέλια ουσία, περιόστεο) καθορίζει τη διαφορική διάγνωση.*

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
30	Για συλλογή υγρού δεν δόθηκαν περιεχόμενο και μέτρηση.	«**[.. x .. mm]**, με περιφερική ενίσχυση, αέρας εντός **[όχι/ναι]** — συλλογή υγρού.»	*Η απόφαση για παροχέτευση λαμβάνεται με βάση το μέγεθος, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του τοιχώματος.*

ΟΜΑΔΑ 5

Συμπέρασμα

8 λάθη · Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
31	Το Συμπέρασμα είναι αντίγραφο των Ευρημάτων.	Στο Συμπέρασμα μόνο τα σημαντικά ευρήματα και η ερμηνεία τους, κατά σειρά σημασίας.	*Το Συμπέρασμα είναι η σύνοψη και η ερμηνεία των ευρημάτων· η αντιγραφή δείχνει ότι δεν έγινε ερμηνεία.*
32	Το Συμπέρασμα δεν απαντά στο κλινικό ερώτημα.	Η πρώτη πρόταση απαντά στο κλινικό ερώτημα: «Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ οξείας σκωληκοειδίτιδας.»	*Ο ιατρός που έγραψε το παραπεμπτικό αναζητά την απάντηση στο ερώτημά του στην πρώτη πρόταση.*
33	Το τυχαίο εύρημα στην πρώτη θέση, το επείγον εύρημα στο τέλος.	Το επείγον εύρημα πάντα πρώτο· τα τυχαία ευρήματα στο τέλος.	*Ο αναγνώστης συχνά διαβάζει μόνο την πρώτη γραμμή.*
34	«Προτείνεται συσχέτιση με την κλινική εικόνα» (σε κάθε γνωμάτευση, χωρίς αιτιολόγηση).	Γράψτε με τι και γιατί πρέπει να γίνει συσχέτιση: «Προτείνεται συσχέτιση με τους εργαστηριακούς δείκτες λοίμωξης.»	*Μια σύσταση συσχέτισης χωρίς αιτιολόγηση δεν μεταφέρει πληροφορία και μειώνει την αξιοπιστία της γνωμάτευσης.*
35	Μακριά και αόριστη λίστα διαφορικής διάγνωσης.	Πρώτα η πιθανότερη διάγνωση και στη συνέχεια το πολύ δύο-τρεις ρεαλιστικές διαφορικές διαγνώσεις.	*Μια λίστα δέκα σημείων δεν προσανατολίζει τον κλινικό ιατρό· τον προσανατολίζει η σειρά πιθανότητας.*
36	«Δεν μπορεί να αποκλειστεί κακοήθεια» (χωρίς αιτιολόγηση).	Γράψτε τα ευρήματα υπέρ ή κατά κακοήθειας και το προτεινόμενο επόμενο βήμα.	*Το «δεν μπορεί να αποκλειστεί» χωρίς αιτιολόγηση δημιουργεί περιττό άγχος και αλυσίδα εξετάσεων.*
37	Ασαφές επίπεδο βεβαιότητας: «Πνευμονία;»	«Συμβατό με πνευμονία» / «υπέρ πνευμονίας» / «πιθανή πνευμονία» — επιλέξτε ποιο από αυτά ισχύει.	*Το ερωτηματικό δεν είναι γλώσσα γνωμάτευσης· το επίπεδο βεβαιότητας δίνεται με τυποποιημένες διατυπώσεις.*
38	Η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση λείπει από το Συμπέρασμα.	«Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση, **[.. στη βλάβη]** υποστροφή.»	*Στην εξέταση παρακολούθησης η κλινική απόφαση λαμβάνεται με βάση τη μεταβολή.*

ΟΜΑΔΑ 6

Σύσταση

4 λάθη · Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
39	«Προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση.»	«Για τον χαρακτηρισμό προτείνεται μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό.»	*Αν δεν γραφτεί ποια εξέταση και γιατί, η σύσταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί.*
40	Σε κάθε εύρημα έχει προστεθεί σύσταση παρακολούθησης.	Ειδική σύσταση μόνο για ευρήματα που θα αλλάξουν την κλινική απόφαση.	*Περιττή σύσταση σημαίνει περιττή εξέταση, κόστος και άγχος για τον ασθενή.*
41	Γράφτηκε διάστημα παρακολούθησης για το οποίο δεν υπάρχει βεβαιότητα.	«Η ανάγκη παρακολούθησης πρέπει να καθοριστεί μαζί με την κλινική ομάδα σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.» — ή ρωτήστε τον επιμελητή σας.	*Λάθος διάστημα μπορεί να βλάψει τον ασθενή· αν δεν είστε βέβαιοι για τον αριθμό, μην τον γράφετε.*
42	Γράφτηκε θεραπευτική σύσταση: «Πρέπει να ξεκινήσει αντιβίωση.»	«Μπορεί να είναι συμβατό με πνευμονία.»	*Η θεραπευτική απόφαση ανήκει στην κλινική ομάδα· η ακτινολογική γνωμάτευση παρέχει διαγνωστική πληροφορία.*

ΟΜΑΔΑ 7

Επείγον εύρημα και ενημέρωση

4 λάθη · Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
43	Το επείγον εύρημα υπάρχει στη γνωμάτευση, αλλά δεν έγινε ενημέρωση.	Ενημερώστε τηλεφωνικά και καταγράψτε στη γνωμάτευση: «Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].»	*Ο χρόνος μέχρι να διαβαστεί η γνωμάτευση μπορεί να είναι κρίσιμος για τον ασθενή.*
44	Η ενημέρωση έγινε, αλλά δεν αναφέρεται στη γνωμάτευση.	«[Ώρα], [τμήμα] — ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο εφημερεύων ιατρός.»	*Η ενημέρωση που δεν καταγράφεται μπορεί ιατρονομικά να θεωρηθεί ότι δεν έγινε.*
45	Καταγραφή ενημέρωσης: «ενημερώθηκε ο γιατρός».	Σε ποιον (ιδιότητα και τμήμα), τι ώρα, με ποιον τρόπο και αν έγινε επανάληψη (read-back).	*Η ασαφής καταγραφή καθιστά αδύνατη την επαλήθευση της ενημέρωσης.*
46	Το επείγον εύρημα βρίσκεται στη μέση του Συμπεράσματος.	Το επείγον εύρημα είναι η πρώτη πρόταση του Συμπεράσματος.	*Ο κλινικός ιατρός που διαβάζει βιαστικά μπορεί να σταματήσει στην πρώτη γραμμή.*

ΟΜΑΔΑ 8

Μορφή και πριν από την υπογραφή

4 λάθη · Τι γράφτηκε → Το σωστό → Γιατί

ΑΡ.	ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ	ΓΙΑΤΙ
47	Στη γνωμάτευση έχουν μείνει αγκύλες ή κείμενο προτύπου.	Πριν από την υπογραφή, τα σημάδια [ ] και «...» αναζητούνται και διαγράφονται.	*Το κείμενο προτύπου που απέμεινε δείχνει ότι η γνωμάτευση στάλθηκε χωρίς να διαβαστεί.*
48	Το όνομα του ασθενούς, η ημερομηνία της εξέτασης ή το παραπεμπτικό δεν ταιριάζουν.	Η ταυτότητα του ασθενούς, η ημερομηνία και το είδος της εξέτασης αντιστοιχίζονται με τη γνωμάτευση.	*Η γνωμάτευση που ανήκει σε λάθος ασθενή είναι από τα σοβαρότερα λάθη γνωμάτευσης.*
49	Χρησιμοποιήθηκαν συντομογραφίες χωρίς επεξήγηση (μη καθιερωμένες).	Γράψτε ολογράφως τη μη καθιερωμένη συντομογραφία την πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε.	*Η γνωμάτευση δεν γράφεται μόνο για ακτινολόγους, αλλά για όλους τους κλινικούς ιατρούς.*
50	Λάθος υπαγόρευσης ή πληκτρολόγησης: «αριστερά» αντί για «δεξιά», «υπερ-» αντί για «υπο-».	Πριν από την υπογραφή, διαβάστε τη γνωμάτευση μία φορά από την αρχή ως το τέλος.	*Ένα λάθος γράμμα μπορεί να αντιστρέψει το νόημα του ευρήματος.*

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Τώρα ανοίξτε το Μπόνους 3 · Γνωμάτευση με Βάση το Κλινικό Ερώτημα: 30 Κλινικά Ερωτήματα. Σημαντικό μέρος των λαθών προκύπτει επειδή η γνωμάτευση δεν απαντά στο κλινικό ερώτημα· δείτε τι πρέπει οπωσδήποτε να απαντά η γνωμάτευση στα 30 συχνότερα ερωτήματα.

Για τα σωστά πρότυπα προτάσεων, μπορείτε να επιστρέψετε στο **Μπόνους 1 · Τράπεζα 200 Συμπερασμάτων Γνωμάτευσης**.